GUIA DE BOLSO

Antimicrobianos na UTI

ANTIBIÓTICOS • ANTIFÚNGICOS ANTIVIRAIS

40 fichas para adultos
Indicação • dose • rim • interações • monitorização

PRÉVIA EDUCACIONAL
Revisão médica humana formal pendente. Conferência documental de fontes em 03/11/2026.

Ferramenta educacional/de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico, os protocolos institucionais ou a avaliação médica individual.

Formato A6 (105 × 148 mm). Índice clicável e marcadores. Fichas longas têm continuação identificada. Sem preços ou dados de pacientes.

Abrir catálogo e atualizações no AldenirMed89

Checagem em 30 segundos

1. Contexto
Adultos. Confirmar infecção, foco, gravidade, alergias, culturas, resistência e possibilidade de controle do foco. A indicação vem antes da dose.

2. Dose e apresentação
Dose basal pressupõe função renal preservada, salvo indicação expressa. Verificar via, diluição, velocidade, peso de cálculo e componentes de associações.

3. Rim e suporte
As tabelas de função renal estável não equivalem a dose na lesão renal aguda, HD, diálise prolongada, CRRT ou ECMO. Identificar a modalidade antes de aplicar a ficha.

4. Ataque e reavaliação
Evitar atrasar tratamento urgente. Ataque e manutenção têm objetivos diferentes; não reduzir automaticamente a dose inicial apenas por uma creatinina isolada. Reavaliar indicação, resposta, foco, culturas, dose e toxicidade diariamente.

Limite: o guia não define tratamento empírico universal, duração de todas as síndromes ou dose em pediatria, gestação, obesidade extrema e suporte extracorpóreo complexo.

A variável certa importa

ClCr não é eGFR
A ficha identifica a variável do ajuste. ClCr usualmente se refere à estimativa Cockcroft-Gault (mL/min). Algumas bulas usam eGFR indexada a 1,73 m²; não trocar métodos sem conferir a referência.

Creatinina instável
Na lesão renal aguda ou recuperação, estimativas podem atrasar a função real. Considerar diurese, tendência, depuração medida quando viável e níveis séricos. Recalcular após mudanças de suporte.

HD intermitente
Confirmar alto/baixo fluxo, calendário, última/próxima sessão e dose após a sessão. Não aplicar o intervalo pós-HD a dias ou modalidades diferentes sem conferir.

CRRT
Registrar modalidade, efluente em mL/kg/h ou L/h, interrupções, função residual e filtro. Os exemplos UCSF pressupõem CVVHD cerca de 2 L/h e TFG residual <10 mL/min; não são esquema universal.

Foscarnet: o nomograma usa mL/min/kg, e não mL/min. **TDM** = monitorização de níveis séricos; individualizar com farmácia clínica/infectologia.

Erros que mudam desfecho

Confundir componentes
Doses de associações podem representar a soma ou um componente. Na ampicilina-sulbactam, distinguir gramas totais e gramas de sulbactam. TMP-SMX é calculado pelo TMP.

Usar uma formulação pela outra
Anfotericina B lipossomal e desoxicolato não são intercambiáveis mg a mg. Posaconazol suspensão, comprimido de liberação retardada e IV têm esquemas distintos.

Perder toxicidade precoce
Rim/diurese; K e Mg; hemograma; enzimas hepáticas; QTc quando pertinente. Nova confusão, mioclonia ou convulsão exigem pensar em neurotoxicidade e acúmulo.

Tratar colonização ou vírus sem indicação
Antimicrobiano exige contexto clínico. Culturas e PCR devem ser interpretadas com sítio e síndrome. Profilaxia e tratamento de infecção ativa não são a mesma dose.

Vancomicina: AUC24/MIC 400-600 é alvo para infecção invasiva por MRSA, assumindo MIC de 1 mg/L; não transformar vale 15-20 isolado em alvo universal.

Índice - antibióticos

ANTIBIÓTICOS

Amicacina (amikacina) 7
Ampicilina 8
Ampicilina-sulbactam 9
Azitromicina 10
Cefazolina 11
Cefepima 12
Cefiderocol 13
Ceftazidima-avibactam 14
Ceftolozana-tazobactam 15
Ceftriaxona 16
Clindamicina 17
Daptomicina 18
Ertapenem 19
Imipenem-cilastatina 20
Levofloxacino 21
Linezolida 22
Meropenem 23
Meropenem-vaborbactam 24
Metronidazol 25
Oxacilina 26
Piperacilina-tazobactam 27
Sulbactam-durlobactam 28
Sulfametoxazol-trimetoprima (TMP-SMX) 29
Vancomicina IV 30

Índice - fungos e vírus

ANTIFÚNGICOS

Anfotericina B DESOXICOLATO IV 31
Anfotericina B LIPOSSOMAL IV 32
Anidulafungina IV 33
Caspofungina IV 34
Flucitosina VO 35
Fluconazol IV/VO 36
Isavuconazol IV/VO 37
Micafungina IV 38
Posaconazol IV / comprimido DR 39
Voriconazol IV/VO 40

ANTIVIRAIS

Aciclovir IV 41
Foscarnet IV 42
Ganciclovir IV 43
Oseltamivir VO/sonda 44
Remdesivir IV 45
Valganciclovir VO 46

Amicacina (amikacina)

INDICAÇÕES ITU complicada por Gram-negativos sensíveis. A dose da ficha refere-se a esse contexto; não é dose universal para choque, pneumonia ou outras infecções invasivas.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 15 mg/kg IV inicial (regime UCSF/IDSA para ITU); doses seguintes e intervalo por farmacocinética/TDM. Peso real; se >120% do ideal, usar peso ajustado conforme protocolo.

RIM / DIÁLISE Regime UCSF de 15 mg/kg, ClCr (mL/min): >=60: a cada 24 h; 40-59: a cada 36 h; 21-39: a cada 48 h. <=20, lesão renal aguda, HD/CRRT: NÃO aplicar nomograma; dose por níveis/especialista.

INTERAÇÕES Nefro/ototóxicos; evitar furosemida/ácido etacrínico quando possível. Pode potencializar bloqueio neuromuscular.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese diária; níveis (UCSF: amostra 6-14 h após primeira dose no regime elegível), audição/equilíbrio e eletrólitos.

NÃO ESQUECER Nomograma é específico da dose/população: não aplicar a esquemas diferentes. Ascite, grandes queimados e gestação também exigem outra estratégia.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Ampicilina

INDICAÇÕES Enterococcus sensível, Listeria e infecções dirigidas. Endocardite requer esquema combinado e especialista.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Infecção sistêmica: 2 g IV a cada 4 h. Dose de manutenção abaixo refere-se a esse esquema.

RIM / DIÁLISE ClCr (mL/min): >50: 2 g a cada 4 h; 30-49: 2 g a cada 6 h; 15-29: 2 g a cada 8 h; <15: 2 g a cada 12 h. HD: 2 g IV a cada 12 h; programar após HD quando coincidir. CRRT: regime próprio por modalidade/efluente. ClCr exatamente 50: confirmar faixa no protocolo/farmácia; a tabela UCSF não delimita esse valor.

INTERAÇÕES Probenecida aumenta exposição; revisar metotrexato e anticoagulantes. Não misturar aminoglicosídeo na mesma solução.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese diariamente na UTI; alergia, hemograma e fígado se curso prolongado.

NÃO ESQUECER Não cobre estafilococos produtores de penicilinase nem Gram-negativos resistentes. Reavaliar culturas e foco.

FONTES: UCSF

Ampicilina-sulbactam

INDICAÇÕES Esquema convencional para germes sensíveis. Alta dose de sulbactam é alternativa combinada para Acinetobacter resistente a carbapenêmicos (CRAB), por diretriz.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Convencional: 3 g IV a cada 6 h (2 g ampicilina + 1 g sulbactam). CRAB: 9 g IV a cada 8 h em 4 h = 6 g + 3 g por dose; total 9 g/dia de SULBACTAM, associado a outro agente.

RIM / DIÁLISE Convencional, ClCr (mL/min): >30: 3 g a cada 6 h; 15-30: 3 g a cada 12 h; <15: 3 g a cada 24 h. HD convencional: 3 g a cada 12 h. ALTA DOSE CRAB: não usar essa tabela; ClCr <60 ou diálise exige ajuste especializado.

INTERAÇÕES Probenecida aumenta exposição; revisar metotrexato e anticoagulantes.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese, Na/K, hemograma, fígado, alergia e resposta microbiológica.

NÃO ESQUECER Alta dose CRAB é regime de diretriz, fora da posologia habitual de bula. Não confundir gramas do produto com gramas de sulbactam; avaliar carga de sódio.

FONTES: UCSF | IDSA

Azitromicina

INDICAÇÕES Pneumonia comunitária grave: cobertura de atípicos, geralmente associada a betalactâmico; não monoterapia empírica de sepse.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 500 mg IV ou VO a cada 24 h. IV: infundir conforme bula, nunca em bolus; 500 mg usualmente em pelo menos 1 h.

RIM / DIÁLISE Sem ajuste renal rotineiro ou por HD/CRRT. Em disfunção renal extrema, monitorar exposição/efeitos; hepatopatia exige avaliação própria.

INTERAÇÕES QT prolongado com amiodarona, antipsicóticos, outros macrolídeos/fluoroquinolonas e azóis; revisar digoxina e varfarina.

MONITORIZAÇÃO QTc, K/Mg e fígado; bradicardia, arritmia e INR se anticoagulado.

NÃO ESQUECER Corrigir hipocalemia/hipomagnesemia e evitar combinação de múltiplos prolongadores de QT quando possível.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Cefazolina

INDICAÇÕES MSSA e outras infecções por Gram-positivos sensíveis; opção dirigida para bacteremia/endocardite conforme avaliação.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Infecção complicada: 2 g IV a cada 8 h.

RIM / DIÁLISE ClCr (mL/min): >30: 2 g a cada 8 h; 10-29: 2 g a cada 12 h; <10: 1 g a cada 24 h. HD estável: 2 g após cada sessão; antes do intervalo de 72 h, 3 g, por protocolo UCSF. CRRT: não usar esse esquema pós-HD. ClCr exatamente 30: confirmar faixa no protocolo/farmácia; a tabela UCSF não delimita esse valor.

INTERAÇÕES Probenecida aumenta exposição; revisar anticoagulantes e risco de coagulopatia.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese, estado mental; hemograma e INR se risco hemorrágico/desnutrição.

NÃO ESQUECER Não cobre MRSA, Enterococcus ou Pseudomonas. Esquema 2/2/3 g exige HD estável e confirmação de calendário.

FONTES: UCSF

Cefepima

INDICAÇÕES Pseudomonas sensível, neutropenia febril e infecções graves por Gram-negativos; uso dirigido em AmpC conforme CIM/sítio.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Infecção grave: 2 g IV a cada 8 h. Infusão prolongada é opção institucional após dose inicial; duração/estabilidade exigem protocolo.

RIM / DIÁLISE Esquema grave, ClCr (mL/min): >60: 2 g a cada 8 h; 30-60: 2 g a cada 12 h; 10-29: 2 g a cada 24 h; <10: 1 g a cada 24 h. HD/CRRT: tabela específica da fonte; não aplicar essas faixas.

INTERAÇÕES Revisar nefrotóxicos e fármacos que alteram estado mental; interação farmacocinética CYP é pouco relevante.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese e avaliação neurológica diária; considerar TDM se disponível. Confusão, mioclonias ou convulsões: reavaliar imediatamente.

NÃO ESQUECER Neurotoxicidade pode ocorrer mesmo com ajuste. Não é opção preferida para infecção invasiva por ESBL.

FONTES: UCSF | IDSA

Cefiderocol

INDICAÇÕES Gram-negativos resistentes com atividade comprovada; uso em CRAB é reservado/individualizado e frequentemente combinado.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 2 g IV a cada 8 h, em 3 h; ClCr >=120 mL/min:2 g a cada 6 h.

RIM / DIÁLISE ClCr mL/min:60-119:2 g a cada 8 h;30-59:1,5 g a cada 8 h;15-29:1 g a cada 8 h;<15 ou HD:750 mg a cada 12 h, após HD quando coincidir. Todas em 3 h. CRRT depende do efluente e função residual: consultar tabela própria de bula.

INTERAÇÕES Revisar nefrotóxicos e compatibilidade; ausência de interação CYP importante não elimina necessidade de conciliação.

MONITORIZAÇÃO Função renal, estado mental/convulsões e resposta/culturas; reconsiderar terapia se deterioração.

NÃO ESQUECER Bula alerta aumento de mortalidade em estudo com infecções resistentes a carbapenêmicos; causa não estabelecida. Escolha por síndrome/isolado, não por rótulo de ultrarresistente.

FONTES: DailyMed / bula | IDSA

Ceftazidima-avibactam

INDICAÇÕES KPC/OXA-48-like e Pseudomonas sensíveis. NÃO cobre metalo-betalactamase isoladamente; associação com aztreonam exige protocolo.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 2,5 g IV (2 g ceftazidima +0,5 g avibactam) a cada 8 h em 3 h, regime otimizado UCSF/IDSA.

RIM / DIÁLISE ClCr mL/min: >50:2,5 g a cada 8 h;31-50:1,25 g a cada 8 h;16-30:0,94 g a cada 12 h;6-15:0,94 g a cada 24 h;<=5:0,94 g a cada 48 h (bula). HD: após sessão; estratégias UTI podem diferir e exigem especialista. CRRT: não extrapolar.

INTERAÇÕES Probenecida pode interferir com eliminação do avibactam; revisar nefrotóxicos. Compatibilidade com aztreonam depende do protocolo.

MONITORIZAÇÃO ClCr diária se instável, estado mental/convulsões, fígado e resposta/culturas.

NÃO ESQUECER Dose renal deve ser aumentada novamente quando rim melhora, para evitar subexposição. Atividade depende do isolado; infusão de 3 h pode diferir da bula local.

FONTES: IDSA | DailyMed / bula

Ceftolozana-tazobactam

INDICAÇÕES Pseudomonas de difícil tratamento sensível; Enterobacterales selecionados conforme sítio e antibiograma. Não trata KPC/MBL por definição.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO BULA: pneumonia 3 g IV (2 g + 1 g) a cada 8 h; ITU complicada/intra-abdominal 1,5 g a cada 8 h. IDSA para resistentes: 3 g a cada 8 h em 3 h, exceto cistite não complicada. Abdome: associar metronidazol.

RIM / DIÁLISE Esquema-base 3 g, ClCr mL/min: >50:3 g a cada 8 h;30-50:1,5 g a cada 8 h;15-29:750 mg a cada 8 h. Para base 1,5 g, as doses são metade. HD pneumonia:2,25 g inicial, depois 450 mg a cada 8 h, pós-HD quando coincidir. CRRT: individualizar.

INTERAÇÕES Revisar nefrotóxicos; poucas interações CYP clinicamente relevantes conhecidas.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/ClCr diária se instável; fígado, hemograma e resposta microbiológica.

NÃO ESQUECER Separar dose de bula da exposição otimizada IDSA. Em Pseudomonas DTR grave, não presumir que a dose de bula da ITU (1,5 g) seja a recomendação IDSA. Infusão de 3 h exige estabilidade local.

FONTES: UCSF | IDSA | IDSA (IDSA AMR2026 - Table 1)

Ceftriaxona

INDICAÇÕES Pneumonia comunitária, meningite e outras infecções por isolados sensíveis; associação com ampicilina em endocardite enterocócica selecionada.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Habitual: 2 g IV a cada 24 h. Meningite ou endocardite enterocócica combinada: 2 g IV a cada 12 h.

RIM / DIÁLISE Geralmente sem ajuste renal ou em HD. Na disfunção renal E hepática graves concomitantes, individualizar; a bula limita a 2 g/dia sem avaliação adicional.

INTERAÇÕES Não misturar ou infundir simultaneamente na mesma linha com soluções IV contendo cálcio; em adultos, uso sequencial requer lavagem adequada. Revisar varfarina.

MONITORIZAÇÃO Hemograma, fígado/bilirrubina, INR se risco; vigiar colestase/pseudolitíase e neurotoxicidade em acúmulo.

NÃO ESQUECER Não cobre Pseudomonas, MRSA ou Enterococcus isoladamente; não usar como atalho para ESBL/AmpC invasivo.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Clindamicina

INDICAÇÕES Adjuvante antitoxina em infecção necrosante estreptocócica/clostridial, junto a cirurgia e outro antimicrobiano apropriado.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Infecção necrosante/estreptococo A: 900 mg IV a cada 8 h. Outras infecções selecionadas: 600 mg IV a cada 8 h.

RIM / DIÁLISE Não requer ajuste renal ou por HD. Disfunção hepática grave e curso prolongado exigem monitorização/individualização.

INTERAÇÕES Potencializa bloqueadores neuromusculares; revisar função respiratória e recuperação do bloqueio.

MONITORIZAÇÃO Diarreia/C. difficile, hemograma e fígado em uso prolongado.

NÃO ESQUECER Não substitui desbridamento ou betalactâmico para estreptococo. Testar resistência induzível (D-test) quando pertinente; não é cobertura empírica universal de MRSA.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Daptomicina

INDICAÇÕES Bacteremia/endocardite direita por Gram-positivos sensíveis; uso em VRE e altas doses requer especialista.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Regime UCSF para infecção invasiva: 8-10 mg/kg IV a cada 24 h. Peso real; se >120% do ideal, UCSF usa peso ajustado.

RIM / DIÁLISE ClCr >=30 mL/min: a cada 24 h; <30: mesma dose a cada 48 h. HD: 8-10 mg/kg após cada sessão sob protocolo. CRRT: regime próprio por fluxo, não usar intervalo da HD.

INTERAÇÕES Estatinas e outros miotóxicos: considerar suspensão temporária/monitorização intensificada.

MONITORIZAÇÃO CPK basal e ao menos semanal; mais frequente em insuficiência renal/estatinas. Vigiar mialgia, função renal e pneumonia eosinofílica.

NÃO ESQUECER NÃO trata pneumonia: inativada pelo surfactante. 8-10 mg/kg é regime institucional/diretriz, superior à dose de bula para algumas indicações.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Ertapenem

INDICAÇÕES Enterobacterales sensíveis, inclusive ESBL em contexto apropriado; foco urinário/abdominal e descalonamento dirigido.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 1 g IV a cada 24 h, usualmente em 30 min.

RIM / DIÁLISE ClCr >30 mL/min: 1 g a cada 24 h; ClCr <=30: 500 mg a cada 24 h. HD: 500 mg/dia com programação/suplementação conforme bula e horário da sessão. CRRT: não extrapolar.

INTERAÇÕES Evitar valproato/divalproato; probenecida aumenta exposição.

MONITORIZAÇÃO Creatinina, estado mental, convulsões, fígado e hemograma conforme curso.

NÃO ESQUECER Não cobre Pseudomonas, Acinetobacter ou Enterococcus. Em paciente crítico/hipoalbuminemia, preferir outro carbapenêmico quando indicado (IDSA).

FONTES: IDSA | Merck/FDA - Invanz

Imipenem-cilastatina

INDICAÇÕES Gram-negativos/anaeróbios sensíveis; dose depende da CIM e síndrome. Não é esquema de meningite.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Esquema de bula aqui: 500 mg de imipenem + 500 mg de cilastatina IV a cada 6 h; infundir 20-30 min.

RIM / DIÁLISE ClCr CG, mL/min, SOMENTE base 500 mg de imipenem a cada 6 h: >=90: 500 mg a cada 6 h; 60-<90: 400 mg a cada 6 h; 30-<60: 300 mg a cada 6 h; 15-<30: 200 mg a cada 6 h. <15: não usar sem HD prevista em até 48 h. HD: protocolo pós-sessão; CRRT: individualizar.

INTERAÇÕES Valproato/divalproato: evitar; ganciclovir: maior risco de convulsões.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/ClCr, estado mental e convulsões; hemograma e fígado.

NÃO ESQUECER Doses se referem ao IMIPENEM, com igual quantidade de cilastatina. Tabelas diferem por esquema-base; não misturar a tabela com regimes de 1 g.

FONTES: DailyMed / bula

Levofloxacino

INDICAÇÕES Pneumonia comunitária/atípicos e Gram-negativos sensíveis; em pneumonia comunitária grave, seguir esquema combinado da diretriz local.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Esquema-base desta ficha:750 mg IV ou VO a cada 24 h. Dose IV de 750 mg: infusão em>=90 min.

RIM / DIÁLISE ClCr mL/min:>=50:750 mg a cada 24 h;20-49:750 mg a cada 48 h;<20 ou HD:750 mg inicial, depois 500 mg a cada 48 h. CRRT: regime próprio por fluxo/residual. Não aplicar a tabelas de base 500 mg.

INTERAÇÕES QT/amiodarona; AINEs: efeitos SNC/convulsões; corticoide: tendinopatia; varfarina:INR. VO: separar de Ca/Mg/Fe/Zn por >=2 h.

MONITORIZAÇÃO QTc, K/Mg, glicemia, função renal e estado mental; dor tendínea, neuropatia e INR quando indicado.

NÃO ESQUECER Evitar em miastenia; ponderar risco de tendinopatia, neuropatia e eventos aórticos em predispostos. Não manter fluoroquinolona se alternativa mais segura equivalente.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Linezolida

INDICAÇÕES Pneumonia por MRSA e infecções por Enterococcus resistente à vancomicina sensível. Não cobre Gram-negativos.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 600 mg IV ou VO a cada 12 h. Infusão IV em 30-120 min.

RIM / DIÁLISE Sem redução renal de bula; em HD, administrar após a sessão quando coincidir. Disfunção renal aumenta risco de trombocitopenia; TDM/ajuste especializado pode ser necessário em curso prolongado, sem redução empírica automática.

INTERAÇÕES Serotoninérgicos (incluindo alguns opioides): monitorar síndrome serotoninérgica. Outros IMAO: contraindicação. Adrenérgicos/vasopressores: monitorar pressão.

MONITORIZAÇÃO Hemograma ao menos semanal (mais frequente na UTI/renal), lactato se acidose inexplicada, neuropatia e sintomas visuais em uso prolongado.

NÃO ESQUECER Clônus, hiperreflexia, agitação e hipertermia exigem reavaliação imediata. Revisão de bula em 06/2026: não tratar toda coprescrição serotoninérgica como contraindicação absoluta.

FONTES: UCSF | Pfizer/FDA - Zyvox

Meropenem

INDICAÇÕES Infecções graves por Gram-negativos sensíveis, ESBL, anaeróbios e meningite, conforme foco e culturas.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Habitual: 1 g IV a cada 8 h. Meningite: 2 g a cada 8 h. Em resistência/hiperfiltração, protocolo pode exigir 2 g e infusão otimizada de 3 h.

RIM / DIÁLISE ClCr (mL/min), esquema-base 1 g: >50: a cada 8 h; 26-50: 1 g a cada 12 h; 10-25: 500 mg a cada 12 h; <10: 500 mg a cada 24 h. Para base 2 g, essas doses são duplicadas. HD/CRRT: esquema específico por foco.

INTERAÇÕES Evitar associação com ácido valproico/divalproato: queda acentuada de níveis e convulsões; aumentar valproato pode não resolver.

MONITORIZAÇÃO Função renal, estado mental/convulsões, hemograma e fígado no uso prolongado.

NÃO ESQUECER Não tratar um isolado resistente apenas aumentando dose. Infusão prolongada requer estabilidade e compatibilidade locais; meningite exige avaliação própria.

FONTES: UCSF | IDSA

Meropenem-vaborbactam

INDICAÇÕES Enterobacterales produtores de KPC sensíveis. Não presume cobertura de NDM/MBL ou OXA-48-like.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 4 g IV (2 g meropenem +2 g vaborbactam) a cada 8 h, em 3 h.

RIM / DIÁLISE ATENÇÃO: eGFR MDRD, mL/min/1,73m² (não ClCr CG): >=50:4 g a cada 8 h;30-<50:2 g a cada 8 h;15-<30:2 g a cada 12 h;<15:1 g a cada 12 h. HD: administrar após sessão quando coincidir. CRRT: regime especializado.

INTERAÇÕES Evitar valproato/divalproato; probenecida não recomendada.

MONITORIZAÇÃO Função renal/eGFR diária se oscilante, estado mental, convulsões, hemograma/fígado e culturas.

NÃO ESQUECER Conferir método renal da bula e não substituir por eGFR desindexada sem validação. Não é intercambiável miligrama por miligrama com meropenem isolado.

FONTES: DailyMed / bula | IDSA

Metronidazol

INDICAÇÕES Anaeróbios, especialmente foco abdominal; associar cobertura aeróbia quando necessária.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Habitual: 500 mg IV/VO a cada 8 h; em foco intra-abdominal selecionado, UCSF usa 500 mg a cada 12 h.

RIM / DIÁLISE ClCr <10 mL/min: UCSF usa 500 mg a cada 12 h. HD: programar após sessão quando possível; reposição se administrado antes/durante depende do caso. CRRT: protocolo específico. Hepatopatia grave: reduzir/individualizar.

INTERAÇÕES Varfarina: aumenta INR. Lítio: toxicidade. Evitar dissulfiram nas últimas 2 semanas; revisar álcool e indutores enzimáticos.

MONITORIZAÇÃO INR se anticoagulado; fígado, estado mental, parestesias e toxicidade cumulativa; níveis de lítio se pertinente.

NÃO ESQUECER Evitar dupla cobertura anaeróbia automática com carbapenêmico ou piperacilina-tazobactam. Não é monoterapia de infecção abdominal polimicrobiana.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Oxacilina

INDICAÇÕES Infecção grave por S. aureus sensível à meticilina (MSSA), inclusive bacteremia; pesquisar e controlar foco.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 2 g IV a cada 4 h, regime institucional para MSSA grave.

RIM / DIÁLISE Sem tabela universal por ClCr. Em disfunção renal importante, sobretudo com hepatopatia, individualizar dose/exposição: a bula recomenda considerar redução se houver acúmulo/toxicidade. HD/CRRT: validar protocolo específico.

INTERAÇÕES Probenecida eleva exposição; revisar metotrexato e carga de sódio de diluentes/apresentação.

MONITORIZAÇÃO Creatinina, K, AST/ALT e hemograma; observar hepatite, nefrite intersticial, neutropenia e neurotoxicidade.

NÃO ESQUECER Não ativa contra MRSA. Doses altas exigem vigilância hepatorrenal; não interpretar ausência de tabela como ausência de risco.

FONTES: Nebraska Medicine - S. aureus bacteremia | DailyMed / bula

Piperacilina-tazobactam

INDICAÇÕES Gram-negativos sensíveis, Pseudomonas e anaeróbios; foco abdominal ou pneumonia conforme ecologia e culturas.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Bula, infusão 30 min: 3,375 g IV a cada 6 h; pneumonia hospitalar: 4,5 g a cada 6 h. 4,5 g = 4 g + 0,5 g. Infusão otimizada exige protocolo próprio.

RIM / DIÁLISE SOMENTE esquema de 30 min: ClCr >40 sem redução; 20-40: 2,25 g a cada 6 h (pneumonia hospitalar: 3,375 g a cada 6 h); <20: 2,25 g a cada 8 h (pneumonia: a cada 6 h). HD: 2,25 g a cada 12 h (pneumonia: a cada 8 h), mais 0,75 g após cada sessão. CRRT: individualizar.

INTERAÇÕES Vancomicina: maior risco de lesão renal; revisar metotrexato, anticoagulantes e bloqueadores neuromusculares.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese, K, hemograma e sódio; INR quando indicado.

NÃO ESQUECER Não transportar a tabela de infusão curta para infusão prolongada. Não é opção preferida para ESBL invasivo ou AmpC de risco moderado invasivo.

FONTES: DailyMed / bula | IDSA

Sulbactam-durlobactam

INDICAÇÕES Bula FDA: pneumonia hospitalar/associada à ventilação por complexo A. baumannii-calcoaceticus sensível. IDSA: CRAB, associado a carbapenêmico.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 2 g IV (1 g sulbactam +1 g durlobactam) a cada 6 h, em 3 h, para ClCr 45-129 mL/min.

RIM / DIÁLISE ClCr CG mL/min, mesma dose 2 g:>=130:a cada 4 h;45-129:a cada 6 h;30-44:a cada 8 h;15-29:a cada 12 h;<15:nova terapia 2 g a cada 12 h por 3 doses (0,12,24 h), depois a cada 24 h; se já em uso e ClCr cair para <15: a cada 24 h. HD: iniciar/aplicar após sessão. CRRT: sem regime universal validado.

INTERAÇÕES Evitar probenecida/outros inibidores OAT1, que podem elevar exposição ao sulbactam.

MONITORIZAÇÃO Função renal diária, K, fígado, hemograma, alergia e resposta/culturas.

NÃO ESQUECER Não confundir com ampicilina-sulbactam. Hiperfiltração começa em>=130, não apenas>130. Acesso/registro/estoque no Brasil devem ser conferidos localmente.

FONTES: DailyMed / bula | IDSA

Sulfametoxazol-trimetoprima (TMP-SMX)

INDICAÇÕES Pneumocistose; Stenotrophomonas/Nocardia sensíveis com estratégia especializada. Dose sempre expressa pelo componente TMP.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Pneumocistose: TMP 15 mg/kg/DIA IV/VO, dividido a cada 8-12 h (UCSF). Infecção sistêmica por Gram-negativo sensível: TMP 10 mg/kg/DIA, dividido a cada 8-12 h. Peso real; obesidade: protocolo de peso ajustado.

RIM / DIÁLISE ClCr 15-30 mL/min: metade da dose diária acima, em tomadas a cada 12-24 h. <15: pneumocistose TMP 5 mg/kg a cada 24 h; sistêmica TMP 2,5 mg/kg a cada 24 h (UCSF). HD: esses mesmos totais por dia, pós-sessão quando coincidir. CRRT: dose própria.

INTERAÇÕES IECA/BRA/espironolactona: hipercalemia; varfarina: INR; metotrexato: mielotoxicidade.

MONITORIZAÇÃO K e creatinina precocemente e seriados; hemograma, Na, fígado e rash. TMP pode aumentar creatinina sem queda real da filtração.

NÃO ESQUECER TMP mg/kg/DIA não é mg/kg por DOSE. Um comprimido forte contém TMP 160 mg + SMX 800 mg. Sulfamida é antibacteriana, embora trate Pneumocystis.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Vancomicina IV

INDICAÇÕES Infecção invasiva por MRSA e outros Gram-positivos sensíveis, conforme foco. Via oral não trata bacteremia.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Crítico: ataque 20-35 mg/kg de peso REAL IV, máximo 3 g (diretriz). Manutenção inicial em função renal normal: 15-20 mg/kg a cada 8-12 h, ajustada por AUC; não é dose fixa universal.

RIM / DIÁLISE Não há tabela de manutenção segura por ClCr isolada no paciente crítico. Ajustar dose/intervalo por concentrações, função renal e evolução. HD e CRRT: regimes próprios com TDM; a dose de ataque não se reduz automaticamente pela ClCr.

INTERAÇÕES Nefrotóxicos, incluindo aminoglicosídeos, anfotericina e piperacilina-tazobactam; cautela com outros ototóxicos.

MONITORIZAÇÃO MRSA invasivo: AUC24 400-600 mg.h/L se CIM presumida 1 mg/L, idealmente nas primeiras 24-48 h; creatinina/diurese diária e níveis conforme estabilidade. Infundir lentamente, <=10 mg/min e >=60 min.

NÃO ESQUECER Vale de 15-20 mg/L isolado não é alvo preferido para todos. Vigiar reação à infusão e lesão renal; AUC exige método validado.

FONTES: IDSA | Consenso vancomicina2020 - texto primário com

Anfotericina B DESOXICOLATO IV

INDICAÇÕES Micoses graves em indicação selecionada; maior toxicidade renal que formulações lipídicas.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Candida invasiva: 0,5-0,7 mg/kg a cada 24 h; até 1 mg/kg/dia em cenários selecionados. Criptococose: esquema específico combinado, em geral 0,7-1 mg/kg/dia. Infundir lentamente em 2-6 h.

RIM / DIÁLISE Não há tabela simples de redução por ClCr; nefrotoxicidade requer avaliar suspensão/troca e correção hidroeletrolítica. Não é hemodialisável; HD não corrige toxicidade. CRRT não elimina o risco renal.

INTERAÇÕES Outros nefrotóxicos, calcineurínicos e perdas de K/Mg. Hipocalemia aumenta toxicidade digitálica/arritmias; pode aumentar toxicidade da flucitosina.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese, K/Mg frequentes no crítico; hemograma/hepatograma e sinais vitais na infusão.

NÃO ESQUECER Conferir formulação antes da prescrição. Anforicin B: glicose 5%, final usual 0,1 mg/mL; não diluir/lavar linha com NaCl. Não substituir por lipossomal mg por mg.

FONTES: Cristália - Anforicin B, bula profissional | IDSA | NIH - tabelas de infecções oportunistas

Anfotericina B LIPOSSOMAL IV

INDICAÇÕES Micoses invasivas conforme agente; opção em Candida resistente/intolerância, criptococose e mucormicose.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Candida invasiva: 3-5 mg/kg a cada 24 h. Meningite criptocócica no HIV: 3-4 mg/kg/dia + flucitosina. Mucormicose: 5-10 mg/kg/dia, SNC geralmente 10 mg/kg/dia, sob especialista.

RIM / DIÁLISE Sem redução renal fixa ou suplemento por HD; geralmente dose usual em CRRT. Toxicidade renal exige reavaliar a escolha. Peso: documentar método; UCSF usa ajustado se peso total >120% do ideal.

INTERAÇÕES Nefrotoxicidade com calcineurínicos/aminoglicosídeos; perdas de K/Mg somam-se às de diuréticos/corticoides.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese, K/Mg com reposição frequente, hemograma/hepatograma e reação de infusão.

NÃO ESQUECER AmBisome: diluir em glicose 5%, nunca NaCl; infusão usual 120 min. Hidratação salina é separada e depende de tolerância. Não trocar formulações mg por mg.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula | NIH - tabelas de infecções oportunistas

Anidulafungina IV

INDICAÇÕES Candidemia e candidíase invasiva; escolha frequente inicial no crítico, conforme espécie/sensibilidade.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Ataque 200 mg no dia 1; depois 100 mg a cada 24 h. Infusão: 200 mg em ≥180 min; 100 mg em ≥90 min; nunca bolus.

RIM / DIÁLISE Sem ajuste por disfunção renal ou HD; sem suplemento pós-HD. Em CRRT, geralmente dose usual; peso, MIC e foco podem exigir avaliação de exposição.

INTERAÇÕES Poucas interações por CYP; revisar hepatotóxicos concomitantes e compatibilidades de infusão.

MONITORIZAÇÃO Hepatograma, reações de infusão, culturas e controle do foco.

NÃO ESQUECER Baixa exposição em urina/SNC/olho. Sem ajuste hepático de bula. ERAXIS contém frutose: contraindicado na intolerância hereditária à frutose; conferir marca.

FONTES: DailyMed / bula

Caspofungina IV

INDICAÇÕES Candidemia/candidíase invasiva; aspergilose de resgate em avaliação especializada.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Ataque 70 mg no dia 1; depois 50 mg a cada 24 h; infundir em cerca de 1 h. Rifampicina: manutenção 70 mg/dia segundo bula.

RIM / DIÁLISE Sem ajuste renal/HD; sem suplemento pós-HD. CRRT geralmente não exige redução. Não confundir ajuste renal com ajuste hepático.

INTERAÇÕES Rifampicina e outros indutores reduzem exposição; ciclosporina pode elevar transaminases; acompanhar tacrolimo.

MONITORIZAÇÃO Hepatograma, reações histamínicas de infusão, resposta/culturas e níveis de interagentes.

NÃO ESQUECER Não diluir em glicose. Child-Pugh 7-9: bula usa manutenção 35 mg/dia e ataque 70 mg; no crítico, reconciliar diagnóstico hepático e risco de subexposição com especialista.

FONTES: DailyMed / bula

Flucitosina VO

INDICAÇÕES Principalmente associada à anfotericina na indução de meningite criptocócica; evitar monoterapia.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Função renal preservada: 25 mg/kg a cada 6 h (100 mg/kg/dia). Documentar peso de cálculo; em obesidade discutir peso ajustado e TDM.

RIM / DIÁLISE ClCr (mL/min), faixas NIH: >40: 25 mg/kg a cada 6 h; 21-40: 25 mg/kg a cada 12 h; 10-20: 25 mg/kg a cada 24 h; <10: 25 mg/kg a cada 48 h. HD: 25-50 mg/kg a cada 48-72 h, após HD, guiado por níveis. CRRT: sem tabela universal; individualizar/TDM.

INTERAÇÕES Anfotericina pode reduzir depuração e elevar toxicidade; revisar mielossupressores e hepatotóxicos.

MONITORIZAÇÃO Hemograma/plaquetas, creatinina e hepatograma frequentes. Pico 2 h pós-dose: alvo NIH 25-100 mg/L; evitar >100 mg/L.

NÃO ESQUECER ClCr de 20 mL/min pertence à faixa de 24 h da tabela NIH adotada. Toxicidade medular/GI/hepática depende da exposição. Sem TDM, pelo menos hemograma 2 vezes/semana, mais frequente no crítico.

FONTES: NIH - tabelas de infecções oportunistas | UCSF

Fluconazol IV/VO

INDICAÇÕES Candidemia por isolado suscetível em paciente selecionado estável; descalonamento e candidíase urinária suscetível.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Candidemia: ataque 800 mg (12 mg/kg) uma vez; depois 400 mg (6 mg/kg) a cada 24 h. IV: até 200 mg/h. Não transpor esta dose para indução de criptococose.

RIM / DIÁLISE ClCr >50 mL/min: manutenção usual; ≤50 sem diálise: 50% da manutenção, mantendo ataque integral (bula). HD: dose integral após a sessão; nos dias sem HD, ajustar pela função residual. CRRT: não aplicar redução de DRC; individualizar modalidade/efluente e foco.

INTERAÇÕES Rever varfarina/INR, tacrolimo/ciclosporina, fenitoína, sulfonilureias e outros prolongadores de QT.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese, hepatograma, K/Mg; ECG e níveis dos interagentes quando indicados.

NÃO ESQUECER Não cobre Aspergillus/Mucorales; C. krusei resistente. Choque ou alto risco de resistência a azol favorece equinocandina inicial.

FONTES: DailyMed / bula | IDSA | UCSF

Isavuconazol IV/VO

INDICAÇÕES Aspergilose invasiva e mucormicose. Não é primeira escolha geral de candidemia.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Dose expressa no ATIVO: 200 mg a cada 8 h por 6 doses; depois 200 mg a cada 24 h (iniciar 12-24 h após último ataque). No Brasil: 200 mg de isavuconazol = 372,6 mg de sulfato de isavuconazônio. IV em ≥1 h, com filtro.

RIM / DIÁLISE Sem ajuste renal ou HD; IV sem SBECD. Em CRRT, habitualmente dose usual, com revisão de exposição/interações e resposta.

INTERAÇÕES CYP3A4: evitar indutores/inibidores fortes contraindicados; acompanhar níveis de tacrolimo/ciclosporina/sirolimo.

MONITORIZAÇÃO Hepatograma, interações e resposta; ECG conforme contexto. TDM em situações selecionadas, sem alvo universal.

NÃO ESQUECER Encurta QT: contraindicado na síndrome familiar de QT curto. Child-Pugh C: dados limitados; decisão especializada. Confirmar se a prescrição/frasco expressa ativo ou pró-fármaco.

FONTES: Knight/United Medical - Cresemba, bula profis

Micafungina IV

INDICAÇÕES Candidemia/candidíase invasiva; outros focos exigem regime específico.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 100 mg a cada 24 h, sem ataque de rotina, em infusão de 1 h. Endocardite/dispositivo cardíaco e esofagite: protocolos usam 150 mg a cada 24 h.

RIM / DIÁLISE Sem ajuste renal ou HD; sem suplemento pós-HD. Habitualmente sem redução em CRRT; individualizar se obesidade, MIC elevada ou foco profundo.

INTERAÇÕES Pode aumentar sirolimo, nifedipino e itraconazol; acompanhar níveis/toxicidade.

MONITORIZAÇÃO Hepatograma, função renal, reações de infusão; hemograma se suspeita de hemólise.

NÃO ESQUECER Baixa exposição em urina/SNC/olho. A dose de candidemia não é universal para esses sítios. Confirmar orientação hepática da bula local.

FONTES: UCSF | DailyMed / bula

Posaconazol IV / comprimido DR

INDICAÇÕES Aspergilose invasiva e profilaxia em alto risco; mucormicose em cenários especializados.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO IV ou comprimido de liberação retardada (DR): 300 mg a cada 12 h no dia 1; depois 300 mg a cada 24 h. IV em cerca de 90 min, acesso central e filtro conforme bula.

RIM / DIÁLISE DR: sem ajuste renal/HD; na disfunção grave vigiar falha/exposição. IV: evitar se TFGe <50 mL/min/1,73 m² pelo SBECD, salvo benefício-risco favorável. CRRT: avaliar veículo/modalidade e TDM; não transpor tabela de DRC.

INTERAÇÕES Inibidor forte CYP3A4: calcineurínicos, venetoclax, estatinas, midazolam e outros fármacos QT. Sirolimo e certas associações são contraindicados.

MONITORIZAÇÃO TDM quando indicado (tratamento, absorção/interações), hepatograma, K/Mg/Ca, ECG, pressão arterial e K.

NÃO ESQUECER Esta ficha NÃO é para suspensão oral convencional/PowderMix: formulações não intercambiáveis. DR inteiro; não triturar de rotina. Pode causar pseudoaldosteronismo (hipertensão/hipoK).

FONTES: DailyMed / bula

Voriconazol IV/VO

INDICAÇÕES Aspergilose invasiva; Fusarium/Scedosporium ou Candida selecionados por identificação/sensibilidade.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Aspergilose: ataque 6 mg/kg IV a cada 12 h por 2 doses; depois 4 mg/kg IV a cada 12 h. VO ≥40 kg: bula usa 200 mg a cada 12 h, ajustável por resposta/TDM. IV em 1-3 h, ≤3 mg/kg/h.

RIM / DIÁLISE VO: sem ajuste renal. IV: evitar se ClCr <50 mL/min pelo SBECD, salvo benefício-risco favorável. HD não exige ajuste do ativo. CRRT: avaliar veículo, modalidade/efluente e TDM; não reduzir automaticamente o ativo.

INTERAÇÕES CYP2C19/2C9/3A4: revisar calcineurínicos, anticoagulantes, anticonvulsivantes, rifamicinas, antineoplásicos e QT; várias associações são contraindicadas.

MONITORIZAÇÃO Vale/TDM (alvo de eficácia/toxicidade pelo foco/protocolo), hepatograma, K/Mg/Ca, ECG e sintomas neurovisuais.

NÃO ESQUECER Não cobre Mucorales. Child-Pugh A/B: manter ataque e reduzir manutenção pela metade (bula). Peso em obesidade e troca IV-VO requerem revisão, sem equivalência automática.

FONTES: DailyMed / bula | UCSF

Aciclovir IV

INDICAÇÕES Encefalite HSV, VZV disseminado e outras infecções HSV graves. Não trata CMV.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Encefalite/VZV disseminado: 10 mg/kg a cada 8 h. HSV sem SNC: usual 5 mg/kg a cada 8 h. Infundir cada dose em ≥1 h, nunca bolus; hidratação conforme tolerância.

RIM / DIÁLISE Bula usa ClCr INDEXADA (mL/min/1,73 m²): >50: dose usual a cada 8 h; >25-50: mesma dose a cada 12 h; >10-25: mesma dose a cada 24 h; ≤10: 50% da dose a cada 24 h. HD: UCSF encefalite/VZV 5 mg/kg a cada 24 h, após sessão nos dias de HD; HSV não SNC 2,5 mg/kg a cada 24 h. CRRT: ajustar efluente/residual/foco.

INTERAÇÕES Calcineurínicos e outros nefrotóxicos elevam risco renal; probenecida reduz depuração.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese e estado mental diariamente; vigiar cristalinúria, mioclonias, tremores e confusão.

NÃO ESQUECER Não confundir ClCr indexada com absoluta. Obesidade: bula usa peso ideal; UCSF prefere ajustado se total >120% do ideal. Documentar método com farmácia; neurotoxicidade pode simular encefalite.

FONTES: DailyMed / bula | UCSF

Foscarnet IV

INDICAÇÕES Reserva para CMV resistente/refratário ou HSV resistente a aciclovir, sob especialista.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO CMV indução com função preservada: 90 mg/kg a cada 12 h. HSV resistente: 40 mg/kg a cada 8-12 h, usando nomograma próprio. Infusão ≤1 mg/kg/min; 90 mg/kg em 90-120 min.

RIM / DIÁLISE ClCr de FOSCARNET em mL/min/kg: (140-idade)/(72×creatinina mg/dL); ×0,85 para mulheres, sem peso no cálculo. Para CMV-base 90 mg/kg 12/12 h: >1,4: 90 mg/kg 12/12 h; >1-1,4: 70 mg/kg 12/12 h; >0,8-1: 50 mg/kg 12/12 h; >0,6-0,8: 80 mg/kg 24/24 h; >0,5-0,6: 60 mg/kg 24/24 h; 0,4-0,5: 50 mg/kg 24/24 h; <0,4: suspender/não recomendado. HD/CRRT: sem esquema de bula validado; protocolo especializado.

INTERAÇÕES Outros nefrotóxicos e fármacos QT; não misturar na mesma solução com cátions divalentes.

MONITORIZAÇÃO Creatinina/diurese, Ca ionizado, Mg/K/P inicialmente diários no crítico; ECG e recalcular dose com mudanças renais.

NÃO ESQUECER Nomograma acima SOMENTE para indução CMV-base90: não usar para HSV ou manutenção. Hidratação individualizada; não impor volume fixo no congesto. Não usar ClCr absoluta/TFGe diretamente neste nomograma.

FONTES: DailyMed / bula | UCSF

Ganciclovir IV

INDICAÇÕES CMV com doença grave/absorção oral incerta, conforme suscetibilidade; DNAemia isolada não define doença de órgão.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Tratamento/indução: 5 mg/kg a cada 12 h. Manutenção/profilaxia, quando indicada: 5 mg/kg a cada 24 h. Infundir em 1 h. Não usar dose de manutenção para doença ainda ativa sem justificativa.

RIM / DIÁLISE ClCr mL/min, INDUÇÃO: ≥70: 5 mg/kg a cada 12 h; 50-69: 2,5 mg/kg a cada 12 h; 25-49: 2,5 mg/kg a cada 24 h; 10-24: 1,25 mg/kg a cada 24 h. ClCr <10 sem HD: individualizar com especialista. HD: indução 1,25 mg/kg após cada sessão (usualmente 3/semana); manutenção 0,625 mg/kg pós-HD. CRRT: individualizar modalidade/efluente/residual; não usar faixa de DRC.

INTERAÇÕES Não combinar com maribavir (antagonismo). Imipenem pode aumentar convulsões; micofenolato/quimioterápicos somam mielotoxicidade.

MONITORIZAÇÃO Hemograma/diferencial/plaquetas, creatinina/diurese; CMV-DNA geralmente semanal e avaliação de órgão.

NÃO ESQUECER As reduções renais listadas são de INDUÇÃO; manutenção tem tabela própria. Citopenia exige manejo especializado, sem subdose automática. Peso UCSF ajustado se total >120% do ideal.

FONTES: DailyMed / bula | UCSF

Oseltamivir VO/sonda

INDICAÇÕES Influenza suspeita/confirmada em hospitalizado/grave: iniciar prontamente sem aguardar resultado.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO 75 mg a cada 12 h, usualmente 5 dias. Grave/imunossuprimido pode exigir duração maior conforme evolução/persistência viral. Não dobrar dose rotineiramente.

RIM / DIÁLISE ClCr mL/min, TRATAMENTO: >60: 75 mg a cada 12 h; >30-60: 30 mg a cada 12 h; >10-30: 30 mg a cada 24 h. ≤10 sem diálise: não recomendado por dados insuficientes. HD: 30 mg imediatamente e após cada sessão no curso de 5 dias. DPAC: 30 mg uma vez após troca. CRRT: individualizar modalidade/efluente/residual.

INTERAÇÕES Probenecida aumenta exposição; pode reduzir resposta à vacina influenza viva intranasal. Poucas interações CYP.

MONITORIZAÇÃO Função renal diária, tolerância GI, estado neurológico e evolução respiratória.

NÃO ESQUECER Estas faixas são de tratamento, não profilaxia. Dose oral/enteral não pode ser administrada IV. Deterioração exige procurar complicações, não pressupor resistência.

FONTES: CDC

Remdesivir IV

INDICAÇÕES COVID-19 em elegíveis segundo fase, gravidade e risco. Não é antiviral genérico para outras viroses.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Adulto ≥40 kg: 200 mg no dia 1; depois 100 mg a cada 24 h. Hospitalar usual 5 dias; extensão até 10 conforme resposta/bula. Infundir em 30-120 min; observar reação durante e após.

RIM / DIÁLISE Sem ajuste por insuficiência renal, inclusive HD. Pode administrar sem relação obrigatória com horário da HD. CRRT: dose usual do ativo, acompanhando resposta e função hepática.

INTERAÇÕES Evitar cloroquina/hidroxicloroquina por antagonismo. Revisar outros hepatotóxicos.

MONITORIZAÇÃO ALT/AST/bilirrubina antes e durante; tempo de protrombina conforme contexto; bradicardia e hipersensibilidade.

NÃO ESQUECER Não reinstituir a antiga restrição automática por TFGe <30. Considerar suspensão se ALT >10×LSN; suspender se elevação com inflamação hepática. IDSA desaconselha início rotineiro já em VM invasiva/ECMO.

FONTES: FDA - Veklury, bula | IDSA

Valganciclovir VO

INDICAÇÕES CMV em paciente estável e com absorção oral confiável; profilaxia/manutenção em situações definidas.

DOSE / ADMINISTRAÇÃO Tratamento/indução: 900 mg a cada 12 h com alimentos. Manutenção/profilaxia: 900 mg a cada 24 h, se ClCr ≥60 mL/min.

RIM / DIÁLISE ClCr mL/min, INDUÇÃO / MANUTENÇÃO: ≥60: 900 mg 12/12 h / 900 mg 24/24 h; 40-59: 450 mg 12/12 h / 450 mg 24/24 h; 25-39: 450 mg 24/24 h / 450 mg 48/48 h; 10-24: 450 mg 48/48 h / 450 mg 2 vezes/semana. <10 ou HD: comprimidos sem dose recomendada de bula; preferir ganciclovir IV para início. CRRT: protocolo especializado.

INTERAÇÕES Mesmas interações de ganciclovir; não associar maribavir. Revisar mielossupressores/nefrotóxicos.

MONITORIZAÇÃO Hemograma/plaquetas, função renal, CMV-DNA e evolução clínica; avaliar absorção.

NÃO ESQUECER Não partir/triturar comprimidos; avaliar solução oral/manuseio seguro para sonda. Não é intercambiável mg por mg com ganciclovir. Função renal instável favorece via IV inicialmente.

FONTES: DailyMed / bula | UCSF

Rastreabilidade e atualização

Cada ficha contém links para a diretriz, protocolo institucional ou bula que a fundamenta. Consultas documentais: 03/11/2026. O ano de uma diretriz é diferente da data de consulta.

IDSA AMR 2026 - Resistência Gram-negativa; conferir mecanismo, susceptibilidade e limites de indicação.

UCSF IDMP - Dose adulta e função renal. Protocolo institucional; não é norma universal.

UCSF diálise - HD e CVVHD: respeitar parâmetros e função residual.

NIH - infecções oportunistas - Tabelas renais e infecções oportunistas; populações específicas.

DailyMed / FDA - Bulas por fármaco: método renal, componentes, infusão e interações.

Conferência assistida por IA não equivale a revisão clínica humana. O guia permanece em revisão médica. Bulas brasileiras, registro, disponibilidade, estabilidade e protocolos do serviço devem ser conferidos antes da aplicação.

Dados editáveis, referências específicas e notas desta edição